

ÉVALUATION LOMBAIRE INITIALE

Première consultation rachis lombaire



#01/12
2L

ÉTAPE PARCOURS

TO — Première consultation

DURÉE CHIR

≈ 2 minutes

QUI REMPLIT

Patient · Tablette · 80%

Chirurgien · Ordi · 20%

• Quel est votre principal motif de consultation ?

• Sous-question Renseignez le trajet de votre douleur :

• Quels sont les autres symptômes que vous ressentez ?

• Quel est le côté principal de vos symptômes ?

• Quel est le moment le plus difficile de la journée ?

• Quelle est la position la plus douloureuse ?

• Vos symptômes ont commencé il y a :

• Vos symptômes ont commencé :

• Pour votre problème principal, cochez-les cases correspondant aux traitements déjà entrepris :

• Avez-vous un ancien problème de dos (Scoliose, fracture, cyphose, ...) ?

• Sous-question Quel type de chirurgie ?

LÉGENDE COULEURS

• À toi de remplir

• Champ critique

• Patient ou auto

LE PATIENT
REMPLOIT SUR
TABLETTE EN
SALLE D'ATTENTE

- Motif principal de consultation
- Trajet de la douleur
- Symptômes associés
- Côté principal des symptômes
- + 7 autres

TU COMPLÈTES SUR
ORDI PENDANT LA
CONSULTATION

- Imagerie disponible (standards / dynamiques / IRM / scanner)
- Niveau diagnostic lombaire principal
- Diagnostic neurologique principal + détail
- Muscle touché + cotation
- + 7 autres

LE CHAMP QUI
DÉFINIT TOUTE LA

☒ Avez-vous déjà été opéré du rachis lombaire ?

☒ Sous-question quand, par qui et où ?

☒ Votre problème est-il lié à un accident de travail ?

☒ Sous-question Si oui , date de l'accident

☒ Sous-question Si oui, lesquels :

☒ Prenez-vous des médicaments pour les douleurs lombaires ?

☒ Evaluez l'intensité de votre douleur DANS LE BAS DU DOS sur la dernière semaine, sur une échelle de 0 (pas de douleur) à 10 (douleurs insupportables) :

☒ Evaluez l'intensité de votre douleur DANS LA(LES) JAMBE(S) sur la dernière semaine sur une échelle de 0 (pas de douleur) à 10 (douleurs insupportables) :

☐ Quels sont les examens d'imagerie disponible(s) pour faire le diagnostic ?

☐ Sous-question standards / dynamiques

☐ NIVEAU DIAGNOSTIC LOMBAIRE PRINCIPALE

☐ DIAGNOSTIC LOMBAIRE NEUROLOGIQUE PRINCIPALE

☐ Sous-question DETAIL DIAGNOSTIC NEURO

☐ Sous-question MUSCLE

☐ Sous-question DETAIL COTATION SUR LE MUSCLE LE PLUS TOUCHE

☐ DIAGNOSTIC LOMBAIRE QUI EXPLIQUE LA SYMPTOMATOLOGIE PRINCIPALE

☐ Sous-question Type de hernie

☐ Sous-question Côté hernie

☐ Sous-question Récidive de Hernie Discale

☐ Sous-question Migrée

☐ Sous-question Grade sténose (schizas)

☐ Sous-question Grade SPL (méyering)

SUITE

- PROJET THÉRAPEUTIQUE LOMBAIRE — médical ou chirurgical

☐ Sous-question GRADE SPL DEG

☐ Sous-question Type Modic

☐ Sous-question Stade de Pfirrmann

☐ Sous-question Air intra discale au scanner

☐ Sous-question Détail du Diagnostic autre :

☐ Sous-question Coté sténose foraminale

☐ Sous-question coté sténose récessus

☐ Sous-question lié à :

☒ Sous-question Classification MSU

☐ PROJET THERAPEUTIQUE LOMBAIRE

☐ Lésion associée sur l'imagerie

☐ Sous-question Niveau

10

LE PATIENT EN FAIT DÉJÀ 80%.

Il te reste 10 cases. Pas une de plus.

CASES

POURQUOI CE 2L BIEN REMPLI CHANGE TOUT

- C'est le TO de chaque patient. Sans lui, aucune comparaison post-op n'est possible.
- Le PROJET THÉRAPEUTIQUE est la variable cible Y de toutes nos études (médical vs chirurgical).
- Les grades radiologiques (Pfirrmann, Modic, Schizas, Méyerding) alimentent la stratification de gravité.

- Études en cours qui en dépendent : ACCEPT (1 000 patients hernie), CLE 2023/2024.
- Sans le 2L de référence, le patient n'entre dans aucune étude SRC.

POSITION DANS LE PARCOURS SRC

